

Ex sogro Bruno

NS

RICARDO FAJARDO FERREIRA

IDADE: 67 anos PESO: 97 ALTURA: 164 PROFISSÃO: Militar CTA
SINTOMAS: ronco; sonolência diurna
QUEIXAS: hãhãhã
MEDICAMENTOS: HRS (sonolência), Prokta (Neuro) total, Ricaroxolona,
Clonidato Tansulone
MÉDICO: Dr. Dra. Virginia (otomina)
EXERCÍCIO FÍSICO: fustuapia / fono
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 23h30' HORA QUE ACORDA: 5h30'
COCHILO (X)SIM ()NÃO DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO
FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: moving BANHEIRO: sum
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 99 e/h SPO2: 67%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
CIRURGIAS: ()NASAL ()AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: sum Asma / Bronquite Hto / pneumo.
COMORBIDADE: (S)RESPIRATÓRIA (S)ENDÓCRINA (S)CARDÍACA
(S)ORTOPÉDICA (S)NEUROLÓGICA ()OUTROS

Cond. App/2022 14 dias TOT/VII (3 mês internado)

16/10/23 - Avaliação - adaptado } DreamStation
Auto 5 a 12
max Dream Full (M).

24/10/23 - P: 6,9 cmH₂O média Pico: 9,2 cmH₂O
IAH = 58,8 e/h
m. de uso = 3h20' * usou a máquina do contínuo *
fuga excessiva oriento e ajusto.

01/11/23 - P: 10,4 cmH₂O
P90 = 12 cmH₂O
IAH = 6,8 e/h
m. de uso = 5h16' - melhora sonolência -
- melhora boca seca -
SPO2 mais baixa de manhã 89%
SPO2 durante o dia ~ 93% ~ 95%

17/11/23 - P: 10,9
IAH = 5,7 e/h
m. de uso: 6hs

Troco p/ o BIPAP 14x10 automático. fuso.

04/12/23 - P: 14 x 10 cmH₂O
IAH = 0,6 e/h
m. de uso: 6h14' - acordou mais vezes durante a noite
- usou o BIPAP de dia

→ mediana (12,4 x 10,6) → ajusto pressão. fuso.

05/01
2024

IPAP: 14
med: 12,7
P95: 13,8

EPAP: 10
med: 10,9
P95: 12

- melhora sonolência

IAH = 0,3 l/h

média uso = 5h50'

fuga = 7 l/min

VC comente = 260 ml ~ 340 ml
FR: 23 ~ 26 rpm
Vol min = 6,4 l/min ~ 7,4 l/min

($\rightarrow$ IPAP 12,6 x EPAP 10,4 $\rightarrow$ config atual IAH = 0,4 l/h.)

05/02
2024

IPAP: 12,6 cmH₂O

EPAP: 10,4 cmH₂O

IAH = 0,2 l/h

m uso = 6h12

fuga = 31 l/min $\rightarrow$ ajuste másc.

- Pulator Bem ajustado

- melhora da movimentação ataca

- Relata dificuldade na
deglutição $\rightarrow$ engasgo.

- vai fazer nasofibrosopia p/
investigação.

- está fazendo fono, relata disfasia.

04/03
24

IPAP = 12,5 cmH₂O

EPAP = 10,6 cmH₂O

IAH = 0,1 l/h

m. de uso = 6hr

fuga = 66 lpm. $\rightarrow$ ajustar másc.

dua.

15/04
24

IPAP 12,6 x EPAP 10,6 cmH₂O

m. de uso: 6h40 lpm.

fuga = 33,6 lpm

relata estar se sentindo bem / ajuste máscara
dua

$\uparrow$ IPAP: 13

27/05/24 IPAP = 12,7 cmH₂O

EPAP = 10,5 cmH₂O

IAH = 0,1 l/h

m. de uso: 6h37m

Bem adaptada

Natache

24/06/24

IPAP = 13 cmH₂O

EPAP = 10,4 cmH₂O

IAH = 0,1 l/h

m de uso: 6h39 m

12,8 cmH₂O (percentil)

Bem adaptada

26/08/24

IPAP: 13 cmH₂O

EPAP: 10,6 cmH₂O

PS: 2,2 cmH₂O

IAH = 0,3 l/h

m uso = 6h38'

fuga 55 l/min

Natache

mando máx Miraz Quattro

Vol ~ 380 ml

FR ~ 22

* levou bojo Dream Full (M) *

13x10x4

8/10/24 IPAP = 13,0 cmH₂O

EPAP = 10,4 cmH₂O

PS: 2,2 cmH₂O

IAH = 0,1 elv

m. uso: 6h 22 min

fuga = 42 l/min

Bem adaptado

sem queixas

FR: 21 upm

Vol. Corrente ~ 340 ml

Silvia

13/01/25 IPA = 12,7 EPAP = 10,5 cmH₂O

IAH = 0,1 elv

m. de uso: 6h 18'

Relatório

fua.

24/02/2025 ~~IPAP~~ até 12/01/2025

IPAP = 13

PS: 2,2 cmH₂O

EPAP inicial: 9,0 cmH₂O

EPAP = 10,4

m. uso = 6,5 min

* novo filtro *

IAH = 0,0 elv

fuga = 33 l/min

Quanto Agente márc; f. umidif.

Silvia

31/03/2025 IPAP = 12,7 EPAP = 10,6

Bem adaptado

IAH = 0,1 elv

m. uso = 6h 30 min

fuga = 25 l/min

fazendo bi-velta em casa Silvia

melhora mobilil

iniciar hidroclorazida

02/06 IPAP = 12,7 / EPAP = 10,6

I, E, 1: 1,47

25 IAH = 0,1 elv

m. de uso: 6h 25'

fuga = 22,8 l/min

Bicicleta 20' (5x)

fua.

Nome: RICARDO FAJARDO FERREIRA

Data de Nascimento: 27-10-1956

IMC: 36,81

Sexo: Masculino

Data do exame: 06-09-2023

Peso: 99 kg

Altura: 1,64 m

Médico: DRA. VIRGINIA GOMES

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 06-09-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 489,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 5,5 e 127,5 minutos. O tempo total de sono foi de 380,5 min, eficiência de 77,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 73,7%; estágio N3: 4,9%; sono REM: 19,4%. O índice de despertares foi de 63,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 99,8/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 628 hipopnéias. A SpO2 média foi de 83% e a mínima de 67%, permanecendo 92,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 44 - 115 bpm e NREM de 43 - 111 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 99,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=67%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

ckv

PACIENTE: RICARDO FAJARDO FERREIRA
66 anos DN - 27/10/1956

ID Paciente: 000001131008
Agendamento: 04/10/2023 - 08:00
Atendimento: 04/10/2023 - 09:20

ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS

SOLICITANTE: DR(A) RUSCHANSKY VILELA DE AZEVEDO

ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS

Exame realizado com transdutor multifrequencial em modo B, color e espectral, com análise em secções transversais e longitudinais de carótidas comuns, internas, externas e vertebrais.

Direita:

Carótida comum com morfologia e calibre preservados, complexo miointimal com 1,0 mm de espessura, fluxo bifásico.
Carótida interna com morfologia e calibre preservados, sem placas, com fluxo bifásico.
Carótida externa com morfologia e calibre preservados, sem placas, com fluxo trifásico.
Vertebral com morfologia e calibre preservados, com fluxo bifásico em sentido cefálico.

Esquerda:

Carótida comum com morfologia e calibre preservados, complexo miointimal com 1,0 mm de espessura, fluxo bifásico.
Carótida interna com morfologia e calibre preservados, sem placas, com fluxo bifásico.
Carótida externa com morfologia e calibre preservados, sem placas, com fluxo trifásico.
Vertebral com morfologia e calibre preservados, com fluxo bifásico em sentido cefálico.

Conclusão:

- COMPLEXO MIOINTIMAL ESPESSADO BILATERAL.
- Ausência de estenoses hemodinamicamente significativas em sistema carotídeo.
- Artérias vertebrais com fluxo em direção cefálica, sem estenoses hemodinamicamente significativas.

		VPS (cm/s)	VDF (cm/s)
DIREITA	ACC	90	18
	ACI	53	16
	ACE	79	12
	VERT	20	5
ESQUERDA	ACC	76	10
	ACI	77	19
	ACE	95	13
	VERT	49	12

VPS: Velocidade de Pico Sistólico

VDF: Velocidade Diastólica Final

ACC: Artéria Carótida Comum

ACI: Artéria Carótida Interna

ACE: Artéria Carótida Externa

VERT: Artéria Vertebral